6.7.1. 장기기증

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	장기이식센터				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 6.7 장기이식관리 JCI Standard 7th Edition: PCC.6, 6.1, COP.8~9.3

제1조 (목적)

1. 세브란스병원 장기기증 정책의 목적은 장기등의 기증에 관한 사항을 규정하므로 관련된 환자와 법정대리인에게 장기등의 기증에 대해 지지하고 기증방침과 기증과정의 적정성을 도모하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 장기등: 사람의 내장이나 그 밖에 손상되거나 정지된 기능을 회복하기 위하여 이식이 필요한 조직으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
   1) 신장·간장·췌장·심장·폐
   2) 말초혈(조혈모세포를 이식할 목적으로 채취하는 경우에 한정한다)·골수·안구
   3) 뼈·피부·근육·신경·혈관 등으로 구성된 복합조직으로서의 손·팔 또는 발·다리
   4) 장기등 이식에 관한 법률에 따라 장기등이식윤리위원회의 심의를 거쳐 보건복지부장관이 결정·고시한 것
   5) 그 밖에 사람의 내장 또는 조직 중 기능회복을 위하여 적출·이식할 수 있는 것으로서 대통령령으로 정하는 것
2. 뇌사: 대뇌, 소뇌 및 뇌간의 세 부분이 모두 회복될 수 없는 불가역적 병변을 일으킨 상태로 자기 호흡이 없고 인공호흡기에 의존해 기본적인 활력징후만을 유지하는 상태를 말한다.
3. 뇌사 장기 기증자: 뇌사에 이른 자를 '장기등 이식에 관한 법률'에 의거하여 뇌사판정을 시행 후 장기를 기증하는 자를 말한다.
4. 장기기증: 뇌사상태인 환자나 순환정지 상태의 환자 또는 살아 있는 자가 장기가 필요한 이식 대기자에게 가족들의 동의나 본인의 서면동의 혹은 민법의 유언 규정에 의한 유언에 따라 장기를 기증하는 것이며 사망한 환자의 경우도 장기기증이 가능한 경우 이와 동일하다.
5. 보건복지부 국립장기조직혈액관리원(National Institute of Organ Tissue and Blood Management): 장기등 이식에 관한 사항을 적정하게 관리하기 위하여 보건복지부 소속기관 중에서 보건복지부령이 정하는 기관이다.

제3조 (절차)

1. 뇌사추정자
   1) 의뢰 절차
      (1) 뇌사 추정자 발생 시 한국장기조직기증원과 뇌사 추정자 발생 병원에서는

세브란스병원 장기이식센터에 이를 의뢰할 수 있으며 이송 후 중환자실 전담 전문의가 관리한다.

(2) 뇌사추정자에 대해 우선 장기이식 관련 전문의가 환자를 사정하여 임상적으로 뇌사로 진행 중인 환자인지, 장기기증이 가능한지 여부를 판단하여야 한다. 타병원에서 발생시에는 장기이식관련 전문의와 장기이식코디네이터는 환자 이송에 책임을 갖는다.

(3) 환자를 이송하기 전 장기이식코디네이터는 법적 규정에 의거하여 법정대리인에게 정보를 제공하고 동의를 득하여야 하며, 반드시 법적 선순위 법정대리인 1인이 아래의 법정 서식에 서면 동의하여야 한다.

① 장기등 기증자 등록 신청서 및 장기기증동의서(세브란스병원 서식)

② 뇌사판정 신청서

③ 법적 선순위 법정대리인 확인을 위하여 관계 서류(가족관계확인서, 주민등록등본 등)를 법정대리인에게 요청할 수 있으며 주민등록등본으로 확인이 가능한 경우 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 의뢰하여 조회한다.

2) 뇌사판정

(1) 뇌사의 판정은 1, 2차 뇌사조사와 평탄뇌파 확인 후 뇌사판정위원회의 만장일치 찬성과 기관장의 최종 승인에 의하여 판정된다.

(2) 뇌사 조사

① 뇌사의 조사는 법의 규정에 의거 신경과 전문의 1인을 포함한 2인의 전문의가 법적 규정에 의거 2차에 걸친 뇌사 조사를 시행한다. 6세 이상의 경우 6시간 간격으로 2회 실시한다.

② 6세 미만의 경우에는 1차와 2차 뇌사조사의 간격은 아래와 같다.

a. 2월 이상 1세 미만인 소아 48시간

b. 1세 이상 6세 미만인 소아 24시간

③ 1세 이상인 뇌사추정자에 대하여는 2차에 걸친 뇌사 조사가 종료된 후에는 뇌파검사를 시행하여 30분 이상 평탄 뇌파가 있는지 확정 검사를 시행하며, 생후 2월 이상 1세 미만인 자에 대해서는 1차 뇌사조사와 2차 뇌사조사 후 뇌파검사를 시행한다.

(3) 뇌사조사가 완료된 후 뇌사 판정위원회를 소집하여 뇌사의 판정을 확정하며 뇌사조사를 시행한 담당 의사는 회의에 참석하여 뇌사조사 결과를 보고한다. 위원회는 회의록과 그 결과를 작성하여 기관장의 승인을 득한다.

3) 가족(법정대리인) 지지

(1) 위기상황에 처해 있으며 불안이 극심한 가족(법정대리인)들을 위하여 뇌사장기기증 관리에 참여하는 모든 의료진은 장기기증이 원활히 이루어지도록 하며 그 진행 과정 중에 가족(법정대리인)들에게 심리적 안정을 제공하도록 최선을 다한다.

(2) 기증자의 가족(법정대리인)들에게는 편안한 공간을 제공하고, 면회가 가능할 수 있도록 지원한다.

(3) 기증자의 담당 의료진은 장기기증자 관리 시작 전 기증자의 의료적 상황과 향후 진행과정을 상세히 가족(법정대리인)들에게 설명하여 준다.

(4) 기증자의 담당 의료진은 장기적출을 위해 수술실로 이송 전 가족(법정대리인)들이

최종 면회를 할 수 있도록 하고 장기기증자 관리 결과, 적출 과정과 장례과정을 설명한다.

4) 진료 시 고려사항

(1) 뇌사판정위원회 완료시간을 장기등 이식에 관한 법률에 의거, 뇌사 장기기증자의 사망시각으로 한다.

(2) 뇌사 판정이 진행되는 동안 동시에 뇌사 장기기증자가 장기를 적정한 상태에서 기증 가능할 수 있도록 의료적 관리를 시행한다.

(3) 뇌사 장기기증자에게 장기이식법과 규정에서 정한 진단의학검사와 면역학 검사, 초음파 검사, 심초음파 검사, 폐기능 검사 등 특수검사를 시행하며 그 결과에 따라 각 장기의 기증 가능 여부를 평가한다.

(4) 뇌사 장기기증자의 적정상태를 유지하기 위하여 약물을 사용하고 수액을 공급하며 혈압, 맥박, 중심 정맥압을 계속 모니터링한다.

(5) 검사 결과와 뇌사 장기기증자의 상태를 수시로 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 보고하여 이식대기자 선정이 원활히 이루어질 수 있도록 한다.

(6) 장기적출을 위해 장기가 수혜 선정된 이식의료기관의 수술팀과 수술시간을 조정하며 가능한 빠른 시간 내에 장기 적출이 시행되어 최적의 상태로 장기가 기증될 수 있도록 한다.

5) 행정적 관리

(1) 사고사인 경우 뇌사 장기기증자 관리 전 경찰서 신고 유무를 확인하고 뇌사판정 후 담당 검찰로부터 검시 전 적출 승인을 득한다.

(2) 뇌사 장기기증자 관리가 종료된 후 동의서류, 가족관계증명서, 뇌사판정서 및 검사결과지를 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 제출한다.

6) 장기기증자의 장례

(1) 뇌사 장기기증자가 이송될 장례식장을 미리 조정하여 둔다.

(2) 뇌사 장기기증자가 장기가 적출된 후 장례식장으로 이송할 때는 최대한 안전하게 주의를 다하여 2인이상 적정 인원이 이송을 수행한다.

(3) 뇌사 장기기증자가 발인 이전에 사망진단서를 받을 수 있도록 주치의(담당교수)는 빠른 시간 내에 진단서를 발급하고 장기이식코디네이터는 직접 가족(법정대리인)에게 전달한다.

(4) 변사나 사고사의 경우에는 경찰에서 요구하는 사진을 수술실에서 촬영하여 전달하며 경찰에서 요구하는 서류를 장기이식코디네이터가 준비하여 가족(법정대리인)에게 전달한다.

2. 살아있는 자로부터의 장기기증

1) 의뢰절차: 살아있는 장기기증자가 있는 장기이식대상자의 각 진료과의 의료진은 장기이식센터에 협의 진료를 의뢰한다.

(1) 협의진료를 의뢰 받은 장기이식센터 의료진과 장기이식코디네이터는 이식대상자와 장기 기증자의 상담을 통해 장기이식과 관련된 의학적, 행정적 제반 절차에 대하여 설명한다.

(2) 장기이식코디네이터와 장기이식센터 의료진은 장기이식법에서 정한 검사 및

장기이식센터의 의학적 표준에 따라 이식적합성 검사를 시행하고 이식대상자와 장기기증자가 의학적으로 이식과 적출이 가능하다고 판단한 경우에만 장기이식을 시행한다.

(3) 살아있는 자로서 16세 미만인 자(단, 골수는 제외), 임부, 해산한 날부터 3월이 경과하지 아니한 자, 정신질환자, 정신지체인, 마약, 대마 또는 향정신성의약품에 중독된 자로부터는 장기등의 적출을 하지 아니한다.

(4) 살아있는 자로부터의 적출 가능한 장기는 신장 1개와 골수, 간장, 폐장, 췌장, 췌도 및 소장의 의학적으로 인정되는 범위에서의 그 일부이다.

2) 기증자 및 법정대리인 지지

(1) 살아있는 장기기증자의 자유로운 의사결정을 위해 이식팀에 소속되지 않은 옹호자를 두어 장기기증자의 의사결정 과정에서 강압과 압력을 받지 않도록 보호해준다.

(2) 옹호자는 살아있는 장기기증자의 의사결정 과정에서 장기기증에 관한 정보를 제공하고 제반 사항을 숙고한 후 자발적으로 장기기증 의사를 결정할 수 있도록 지지해준다.

(3) 장기이식코디네이터와 주치의(담당교수)는 살아있는 기증자의 의료적 상황과 향후 진행과정을 상세히 이식대상자와 살아있는 장기기증자 가족에게 설명한다.

① 장기기증을 자유롭게 결정할 수 있는 권리

② 잠재적인 심리사회적 위험

③ 잠재적인 합병증 위험 및 건강문제

④ 수혜예정자의 대체치료법

⑤ 언제든지 기증 동의를 철회할 수 있는 권리 등

3) 진료 시 고려사항

(1) 장기기증자는 장기등 이식에 관한 법률에서 정한 검사 및 장기이식센터의 의학적 표준에 따른 신체, 심리사회적 검사를 시행하고, 그 결과에 따라 각 장기의 기증 여부를 평가한다.

(2) 장기이식팀은 장기기증자에게 수술 후에도 지속적인 사회심리적인 지지를 제공한다.

4) 행정적 관리

(1) 장기이식코디네이터는 장기등 이식대상자와 기증자의 관련된 인적 사항 및 의료적 정보를 질병보건통합관리시스템(is.cdc.go.kr)에 입력하고, 이에 관련된 법정 서식 기록은 10년간 보관한다.

5) 해당 의료진은 이식 관련 교육을 이수한다.

3. 장기기증 활성화를 위한 활동

1) 장기기증 활성화를 위한 활동을 시행한다.

(1) 뇌사장기 기증 활성화를 위한 전 직원 대상 교육 및 홍보활동(장기기증 활성화를 위한 포스터 혹은 홍보물 제작 및 게시)을 시행한다.

(2) 뇌사장기 기증에 대한 교육을 의료진 대상으로 정기적으로 실시한다.

2) 장기기증자의 권리 보호 활동

(1) 살아있는 장기기증자 권익보호를 위하여 옹호상담을 시행한다.

(2) 살아있는 장기기증자들에게 장기기증 후 지속적인 사회심리적 지지를 제공한다.

제4조 (부록)

1. 뇌사 추정자 발생 시 신고 절차

제5조 (참고)

1. 장기등 이식에 관한 법률
2. 장기등 이식에 관한 법률 시행령
3. 장기등 이식에 관한 법률 시행규칙

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)